MEDIFLOW · HACKATHON ONE G10

Oracle Next Education & Alura · Grupo 10

Mapa de documentos de teste

Quantos fixtures o MediFlow precisa, quais são e o que cada um prova

PROJETO	MediFlow — triagem, extração e roteamento de documentos clínicos
VERSÃO	1.0 — 19/10/2026
BASE DOCUMENTAL	Projeto_oracle.pdf · Análise de Requisitos v1.1 · Especificação Funcional v1.0
ESCOPO	MVP do hackathon — somente dados fictícios, OCI Always Free

67	12	48	8
fixtures no catálogo	já produzidos	arquivos gerados	simulações sem arquivo

Como este mapa está organizado

— Seção 1 — cobertura: os 8 tipos controlados contra os 4 formatos de entrada.

— Seção 2 — fluxo de decisão que cada fixture exercita (rotina, urgência, ambiguidade, erro).

— Seção 3 — kit de demonstração: os 12 casos prontos, com TXT, PDF, JPG e expected.json.

— Seção 4 — catálogo completo dos 67 fixtures, bloco por bloco, com destino e status esperados.

— Seção 5 — pendências da especificação que ainda travam parte dos testes.

AVISO

Todos os documentos deste catálogo são fictícios: nomes, CRMs, CID e resultados existem apenas para testar o agente. Nenhum dado de paciente real é usado.

1. Cobertura: tipos × formatos

A matriz 8 × 4 é o piso do catálogo. Os números indicam quantos fixtures existem em cada célula.

TIPO DE DOCUMENTO	PDF	PDF escaneado	Imagem	Texto	Total
RECEITUARIO_MEDICO	2	1	4	6	13
LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	5	1	1	2	9
LAUDO_EXAME_IMAGEM	4	1	3	1	9
GUIA_PROCEDIMENTO	2	1	2	3	8
RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	3	1	1	1	6
ATESTADO_MEDICO	1	1	2	2	6
OUTRO	1	1	1	1	4
NAO_IDENTIFICADO	1	—	2	1	4

Leituras que mudam o plano

- OUTRO e NAO_IDENTIFICADO não são tipos que se escrevem: são resultados de classificação. Por isso cada um entra com 3 testes negativos (documento fora da taxonomia ou ilegível).
- JSON não é tipo de documento: é apenas o envelope da API. Um texto enviado como JSON continua sendo um documento de texto.
- PDF digital e PDF escaneado têm caminhos de leitura diferentes (RF-02/RF-04) e por isso colunas separadas.
- Especialidade médica é texto livre (RF-06) — não existe lista fechada e não é preciso um documento por especialidade.

Composição do catálogo por bloco

Bloco	O que cobre	Arquivos	Acumulado
M	Matriz tipos × formatos	24	24
A	Ausência de campos	8	32
B	Fronteira do limiar (0,84 e 0,85)	2	34
C	Conflitos, contradições e alto risco	5	39
S	Urgência + ambiguidade simultâneas	2	41
Q	Qualidade, ilegibilidade e PDFs especiais	8	49
V	Negativos técnicos de entrada	8	57
E	PDF escaneado dos 6 tipos restantes	6	63
D	Diferenciais opcionais	4	67

MÍNIMO LITERAL DOS CRITÉRIOS DE ACEITE (§16)

8 arquivos: texto + um PDF + uma imagem do mesmo caso, mais as 5 variações de campo ausente.
Passa na leitura literal, mas não prova os 5 destinos nem as 8 classes de tipo. Não use como meta.
Meta recomendada: 57 arquivos. Demonstração mínima: 12.

2. Fluxo de decisão que os fixtures exercitam

Cada caminho precisa de pelo menos um documento diferente para ser comprovado.

RF-01 / RF-02
1. ENTRADA
PDF digital · PDF escaneado
Imagem · texto

→

RF-03
2. VALIDAÇÃO
formato, tamanho, MIME
envelope da requisição

→

RF-04
3. LEITURA
Gemini multimodal
classificação + extração

→

RF-16 a RF-19
4. GRAFO
scores, conflitos
regras determinísticas

Cinco desfechos possíveis

URGENTE / CRÍTICO
destino FILA_URGENCIA_MEDICA
alerta simulado registrado
status EM_REVISAO

AMBÍGUO / ILEGÍVEL
destino FILA_REVISAO_HUMANA
campos incertos preservados
status EM_REVISAO

ROTINA (score ≥ 0,85)
FARMACIA · AUDITORIA · PRONTUARIO
revisão apenas se outra regra exigir
status PROCESSADO

Fixture que exercita cada caminho

Caminho	Fixtures	Bloco
Rotina	M-REC-TXT · M-REC-PDF · M-LAB-PDF · M-GUI-PDF · M-ALT-PDF · M-ATE-TXT	M
Urgência	M-REC-IMG · M-IMG-PDF · C-ALTO-RISCO	M · C
Ambiguidade	M-NID-IMG · M-OUT-TXT · A-PAC-NOME · B-084	M · A · B
Urgência + ambiguidade	S-URG-ILEGIVEL · S-URG-SCORE	S
Erro de entrada	V-DOCX · V-VAZIO · V-JSON-MALFORMADO · V-MIME	V
Erro de provedor/OCI	F-GEMINI-TIMEOUT · F-OCI-ORIGINAL (sem arquivo novo)	F

Regras de bolso

— Urgência nunca vira rotina, mesmo com score baixo (RN-03, RNF-02).
— Score combinado = mínimo entre classificação e extração; abaixo de 0,85 obriga revisão (RF-18).
— Cinco ausências obrigam revisão: nome do paciente, idade, nome do médico, CRM e diagnóstico.
— CID, medicamentos e exames ausentes NÃO obrigam revisão por si só (RF-21).
— Nada é preenchido por inferência: ausente fica null e entra em campos_ausentes (RF-15).

3. Kit de demonstração — 12 casos prontos

Cada caso foi gerado em TXT, PDF e JPG, com expected.json ao lado. Caminho: tests/fixtures/demo/

#	ID	Caso	Destino esperado	Status	Rev.
1	M-REC-TXT	Receituário — rotina (texto)	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—
2	M-REC-PDF	Receituário — rotina, 2 medicamentos (PDF)	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—
3	M-REC-IMG	Receituário — urgência com opioide (imagem)	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	SIM
4	M-IMG-PDF	TC de tórax — TEP agudo (PDF)	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	SIM
5	M-LAB-PDF	Hemograma — rotina (PDF)	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—
6	M-GUI-PDF	Guia de ressonância — eletiva (PDF)	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—
7	M-ALT-PDF	Relatório de alta — pneumonia (PDF)	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—
8	M-ATE-TXT	Atestado de comparecimento (texto)	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—
9	M-NID-IMG	Documento ilegível (imagem degradada)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM
10	M-OUT-TXT	Comunicação administrativa (texto)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM
11	A-PAC-NOME	Receita sem nome do paciente (texto)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM
12	B-084	Receita com score forçado 0,84 (texto)	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	SIM

Conteúdo de cada pasta

Arquivo	O que é	Formato
{ID}.txt	Documento em texto puro	UTF-8
{ID}.pdf	Mesma peça em PDF digital, com camada de texto	PDF 1.4
{ID}.jpg	Mesma peça fotografada e levemente inclinada	JPEG 150 dpi
expected.json	Saída esperada: tipo, prioridade, destinos, revisão, asserções	JSON

Cobertura do kit

— 5 destinos lógicos: urgência, farmácia, auditoria de autorizações, prontuário e revisão humana.

— 3 formatos de entrada + 8 classes de tipo (6 clínicos, OUTRO e NAO_IDENTIFICADO).

— 3 cenários obrigatórios do hackathon: rotina, urgência e ambiguidade.

— 2 regras de borda: ausência de campo obrigatório e score abaixo de 0,85.

4. Catálogo completo — 67 fixtures

Rev = requer auditoria humana · OK = fixture já produzido no kit de demonstração

4.1 Bloco M — Matriz tipos × formatos (24)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
M-REC-PDF	RECEITUARIO_MEDICO	Pdf	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓
M-REC-IMG	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓
M-REC-TXT	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	✓
M-LAB-PDF	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-LAB-IMG	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
M-LAB-TXT	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
M-IMG-PDF	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	✓
M-IMG-IMG	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	
M-IMG-TXT	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
M-GUI-PDF	GUIA_PROCEDIMENTO	Pdf	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	✓
M-GUI-IMG	GUIA_PROCEDIMENTO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	
M-GUI-TXT	GUIA_PROCEDIMENTO	Texto	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	
M-ALT-PDF	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-ALT-IMG	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
M-ALT-TXT	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
M-ATE-PDF	ATESTADO_MEDICO	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
M-ATE-IMG	ATESTADO_MEDICO	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
M-ATE-TXT	ATESTADO_MEDICO	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	✓
M-OUT-PDF	OUTRO	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
M-OUT-IMG	OUTRO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
M-OUT-TXT	OUTRO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-NID-PDF	NAO_IDENTIFICADO	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
M-NID-IMG	NAO_IDENTIFICADO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
M-NID-TXT	NAO_IDENTIFICADO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	

4.2 Bloco A — Ausência de campos (8)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
A-PAC-NOME	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
A-PAC-IDADE	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
A-MED-NOME	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
A-MED-CRM	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
A-DIAG	GUIA_PROCEDIMENTO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
A-CID-SO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
A-MEDIC-SO	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
A-EXAMES-SO	ATESTADO_MEDICO	Texto	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	

4.3 Bloco B — Fronteira do limiar (2)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
B-084	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	✓
B-085	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	

4.4 Bloco C — Conflitos e alto risco (5)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
C-CID-CONFLITO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
C-DOSE	RECEITUARIO_MEDICO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
C-PRIORIDADE	GUIA_PROCEDIMENTO	Texto	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
C-DADOS	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
C-ALTO-RISCO	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA	EM_REVISAO	S	

4.5 Bloco S — Urgência + ambiguidade (2)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
S-URG-ILEGIVEL	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
S-URG-SCORE	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf	Urgencia	FILA_URGENCIA_MEDICA + FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	

4. Catálogo completo (continuação)

Rev = requer auditoria humana · OK = fixture já produzido no kit de demonstração

4.6 Bloco Q — Qualidade, ilegibilidade e PDFs especiais (8)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
Q-FOTO-DESFOCO	NAO_IDENTIFICADO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
Q-FOTO-ROTACAO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
Q-FOTO-CORTADA	GUIA_PROCEDIMENTO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
Q-FOTO-BAIXA	ATESTADO_MEDICO	Imagem	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	
Q-PDF-SEM-TEXTO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
Q-PDF-MULTIPAGINA	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
Q-PDF-SENHA	RECEITUARIO_MEDICO	Pdf	Erro	N/A	ERRO_PROCESSAMENTO	—	
Q-PDF-CORROMPIDO	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Erro	N/A	ERRO_PROCESSAMENTO	—	

4.7 Bloco V — Negativos técnicos de entrada (8)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
V-DOCX	N/A	Docx	Erro	N/A	415 FORMATO_NAO_SUPORTA...	—	
V-VAZIO	N/A	Arquivo 0Kb	Erro	N/A	422 CAMPOS_INVALIDOS	—	
V-JSON-MALFORMADO	N/A	Json	Erro	N/A	400 REQUISICAO_INVALIDA	—	
V-ENVELOPE	N/A	Json	Erro	N/A	422 CAMPOS_INVALIDOS	—	
V-SEM-CONTEUDO	N/A	Multipart	Erro	N/A	422 CAMPOS_INVALIDOS	—	
V-ZIP	N/A	Zip	Erro	N/A	415 FORMATO_NAO_SUPORTA...	—	
V-GRANDE	N/A	Arquivo 25Mb	Erro	N/A	413 ARQUIVO_MAIOR_QUE_LIM...	—	
V-MIME	N/A	Pdf Falso	Erro	N/A	415/422 MIME_INVALIDO	—	

4.8 Bloco E — PDF escaneado dos tipos restantes (6)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
E-REC-PDFSCAN	RECEITUARIO_MEDICO	Pdf Digitalizado	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	
E-LAB-PDFSCAN	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
E-GUI-PDFSCAN	GUIA_PROCEDIMENTO	Pdf Digitalizado	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	
E-ALT-PDFSCAN	RELATORIO_ALTA_INTERNACAO	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
E-ATE-PDFSCAN	ATESTADO_MEDICO	Pdf Digitalizado	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
E-OUT-PDFSCAN	OUTRO	Pdf Digitalizado	Ambiguidade	FILA_REVISAO_HUMANA	EM_REVISAO	S	

4.9 Bloco D — Diferenciais opcionais (4)

ID	Tipo	Formato	Cenário	Destino esperado	Status / HTTP	Rev	OK
D-MANUSCRITA	RECEITUARIO_MEDICO	Imagem	Rotina	FARMACIA_HOSPITALAR	PROCESSADO	—	
D-CARIMBO	LAUDO_EXAME_IMAGEM	Imagem	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
D-HEMOGRAMA	LAUDO_EXAME_LABORATORIAL	Pdf	Rotina	PRONTUARIO_ELETRONICO	PROCESSADO	—	
D-GUIA-TISS	GUIA_PROCEDIMENTO	Pdf	Rotina	AUDITORIA_AUTORIZACOES	PROCESSADO	—	

Cada linha corresponde a um arquivo de entrada. Os blocos V e F usam envelope de erro, não JSON de triagem.

5. Pendências que travam parte dos testes

Pontos abertos na especificação v1.0 (§15) que ainda impedem resposta inequívoca em parte dos fixtures.

Pendência	O que fica bloqueado	Recomendação
Limite de tamanho, páginas, MIME, timeout e retry	V-GRANDE, Q-PDF-MULTIPAGINA, F-*	Fixar: 10 MB, 10 páginas, timeout 30 s, 2 retries
Contrato final do upload (multipart × JSON)	V-SEM-CONTEUDO, V-ENVELOPE, V-MIME	Multipart para arquivo; JSON para texto
Dicionário de achado crítico e alto risco	C-CID-CONFLITO, C-DOSE, C-ALTO-RISCO	Criar rules/cid10.csv e rules/medicamentos_alto_risco.csv
Urgência isolada exige revisão?	Todos os casos URGENTE	Spec diz sim (§8.2/§5.3); o exemplo do brief diz não. Padronizar.
Autenticação e autorização	403 e consulta por terceiros	Fora do MVP; se entrar, criar fixture de acesso negado
Política de retenção e exclusão	Teste de persistência no OCI	Definir antes de qualquer dado real (que não deve existir)
Meta de latência e precisão	F-GEMINI-TIMEOUT, F-RETRY	Medir o primeiro pipeline e só então fixar a meta

Como produzir os 55 fixtures restantes

1. Escrever o conteúdo em source/{ID}.md com dados fictícios e marca d'água.
2. Gerar as três rendições: TXT, PDF digital e JPG; para o bloco Q, gerar PDF sem camada de texto.
3. Criar as bordas alterando UM único atributo em relação ao documento base.
4. Preencher expected.json com tipo, prioridade, destinos, revisão, ausências e status.
5. Rodar o pipeline e comparar por asserção, nunca por score exato do LLM.

REGRA DE OURO DOS FIXTURES

Nunca compare score exato do modelo: ele não é probabilidade calibrada (RF-17).
Compare faixas (< 0,85) e, nas bordas, use FIXTURE_MODE para forçar os scores.

6. Arquivos e referências

Tudo versionado no repositório, exceto os PDFs de origem que ficam no Google Drive.

Arquivo	Conteúdo
docs/testes/CATALOGO_DE_DOCUMENTOS_DE_TESTE.md	Catálogo analítico completo, regras e rastreabilidade
docs/testes/Mapa_de_Documentos_de_Teste_MediFlow.pdf	Este documento
tests/fixtures/manifest.csv	Os 67 fixtures em formato de máquina
tests/fixtures/demo/	12 casos × (TXT + PDF + JPG + expected.json)
tests/fixtures/README.md	Convenção de nomes e regras de produção
README.md	Visão do produto, arquitetura e critérios de aceite

Base documental (Google Drive)

— Projeto_oracle.pdf — brief do hackathon: formatos, entregáveis e checklist de avaliação.

— MediFlow_-_Análise_de_Requisitos_v1.1.pdf — requisitos RF/RNF/RN e decisões do time.

— MediFlow_Especificacao_Funcional_v1.0.pdf — §5 vocabulário, §7 requisitos, §8 regras, §16 critérios de aceite.

Este documento e todos os fixtures citados usam exclusivamente dados fictícios, em conformidade com a decisão registrada na seção 15 da especificação funcional. Nenhum nome, CRM, CID ou resultado clínico corresponde a pessoa real.